

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : PR BENDJELLOUL MAYA.

LE TIBIA

PLAN :

I-DEFINITION.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-DIAPHYSE.

B-EPIPHYSE PROXIMALE.

C-EPIPHYSE DISTALE.

I-DEFINITION :

Os long ,volumineux, pair, non symétrique ,formant avec la fibula le squelette de la jambe.Situé à la partie médiane de la jambe, en dedans de la fibula. Il s'articule :

- en haut : avec le fémur ,réalisant l'articulation fémoro-tibiale et avec la fibula réalisant l'articulation tibio-fibulaire proximale.
- et en bas avec le talus réalisant l'articulation talo-crurale, et avec la fibula , réalisant l'articulation tibio-fibulaire distale.

II-DIAPHYSE :

Le corps est prismatique et triangulaire et présente :trois faces et trois bords.

1. **FACE LATERALE** :présente dans sa moitié supérieure une dépression qui donne insertion au muscle tibial antérieur.
2. **FACE MEDIALE** :elle est lisse et sous cutanée, sauf à sa partie supérieure, elle présente des rugosités qui donnent insertion aux muscles sartorius, gracile et semi-tendineux .
3. **FACE POSTERIEURE** : elle est traversée à sa partie supérieure par une crête;c'est la ligne oblique du tibia qui donne insertion au muscle soléaire. Cette ligne partage la face postérieure du tibia en deux segments ;un segment supérieur, triangulaire, donne attache au muscle poplité ;un segment inférieur subdivisé par une crête verticale en deux :une partie médiale qui donne insertion au muscle fléchisseur commun des orteils, et une partie latérale pour le tibial postérieur.

Le foramen nourricier principal de l'os est généralement situé un peu au-dessous de la ligne oblique du tibia.

4. **BORD ANTERIEUR** : saillant et tranchant; c'est la crête du tibia. il se perd en haut sur la tubérosité tibiale.
5. **BORD LATERAL** : appelé bord interosseux, donne insertion à la membrane interosseuse de la jambe.
6. **BORD MEDIAL** : peu marqué.

III-EPIPHYSE PROXIMALE : en forme de pyramide à base supérieure.

On lui décrit une base ou plateau tibial, et deux tubérosités ou condyles.

1-LE PLATEAU TIBIAL OU SURFACE ARTICULAIRE SUPERIEURE DU TIBIA:

Présente trois parties ; deux latérales articulaires : les cavités glénoïdales, et une partie moyenne : l'espace interglénoïdien.

Les cavités glénoïdales sont l'une externe, l'autre interne. Elles s'articulent avec les condyles du fémur.

À leur partie interne elles se relèvent d'une éminence, en formant l'éminence intercondylaire, qui occupe la partie moyenne de l'espace interglénoïdien.

L'espace interglénoïdien est divisée en trois parties : une moyenne et les deux autres sont les aires intercondylaires antérieure et postérieure.

2-CONDYLE LATERAL : il présente :

- en dehors et en arrière la surface articulaire fibulaire pour la tête de la fibula.
- en dehors et en avant, le tubercule de Gerdy qui donne insertion aux muscles tibial antérieur et au fascia lata.

3- CONDYLE MEDIAL : présente :

- En arrière l'empreinte d'insertion du tendon direct du muscle semi-membraneux.

4-LA TUBEROSITE TIBIALE : située à la partie antérieure de l'épiphyse proximale et donne insertion au ligament patellaire.

IV-EPIPHYSE DISTALE :

Moins volumineuse que l'extrémité supérieure, présente un prolongement distal, la malléole médiale. Elle a une forme irrégulièrement cubique, présente donc 5 faces :

- 1- **LA FACE ANTERIEURE** : continue la face latérale de la diaphyse et présente un bourrelet transversal qui donne insertion à la capsule de l'articulation talo- crurale.

- 2- **LA FACE POSTERIEURE** : présente un sillon où passe le tendon du long fléchisseur propre de l'hallux.
- 3- **FACE LATÉRALE** : creusée en gouttière, l'échancrure fibulaire du tibia où se loge l'extrémité distale de la fibula.
- 4- **LA FACE MEDIALE** : elle se prolonge en bas par un processus volumineux, la malléole médiale qui forme une saillie triangulaire à sommet inférieur, cette malléole présente :
 - une face médiale : est sous cutanée.
 - une face latérale : présente une surface articulaire avec le talus.
 - un bord antérieur .
 - un bord postérieure .
 - un sommet : donne attache au ligament latéral interne de l'articulation talo-crurale.
- 5- **FACE INFÉRIEURE** : entièrement revêtue de cartilage, quadrilatère, elle est divisée en deux parties par une crête qui répond à la gorge de la trochlée du talus.

FIN

Références :

Henri Rouvière et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15^e édition, MASSON.

Alain Bouchet et Jacques Cuilleret, Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. tome 3, troisième édition, SIMEP.

LE TIBIA

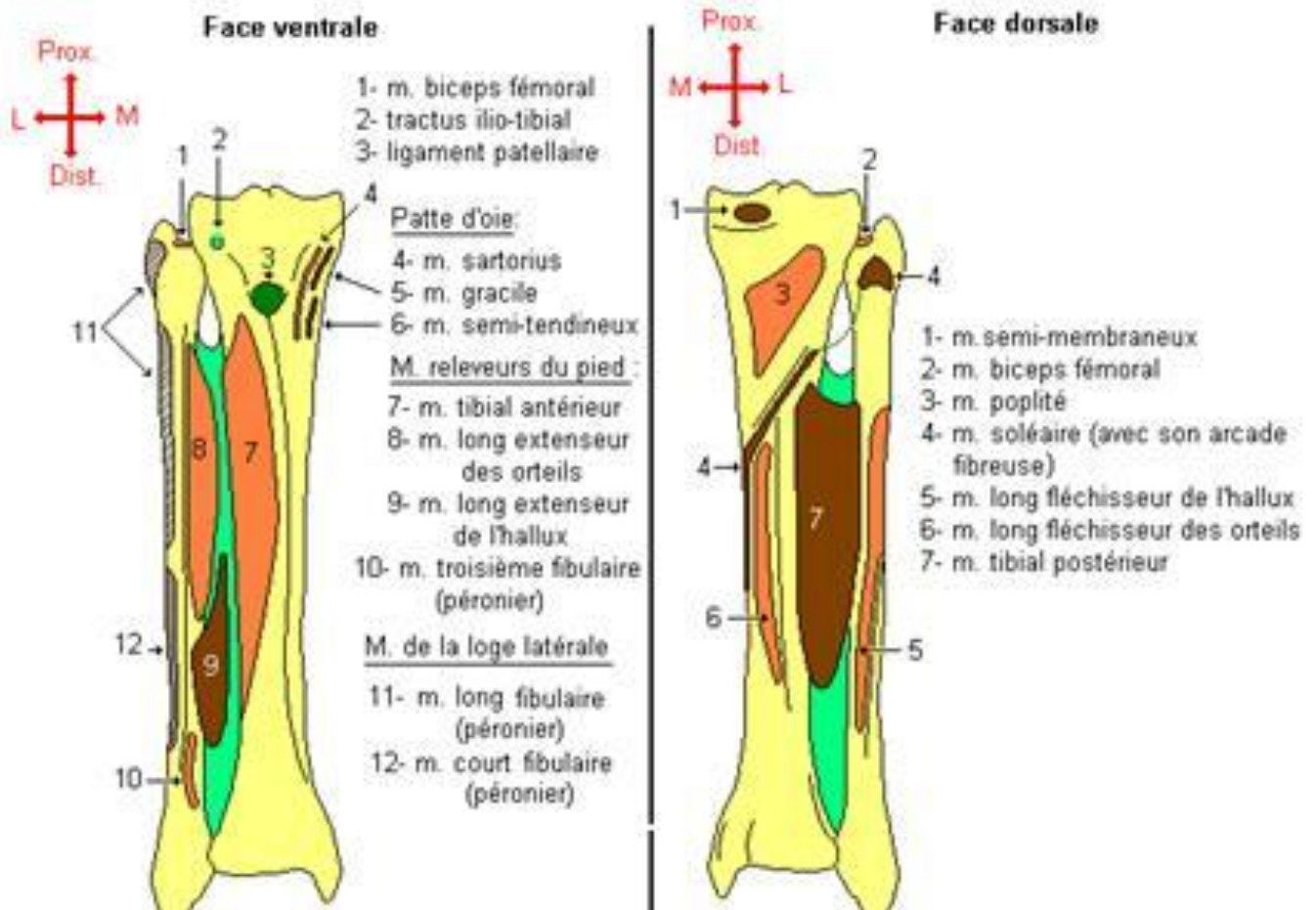
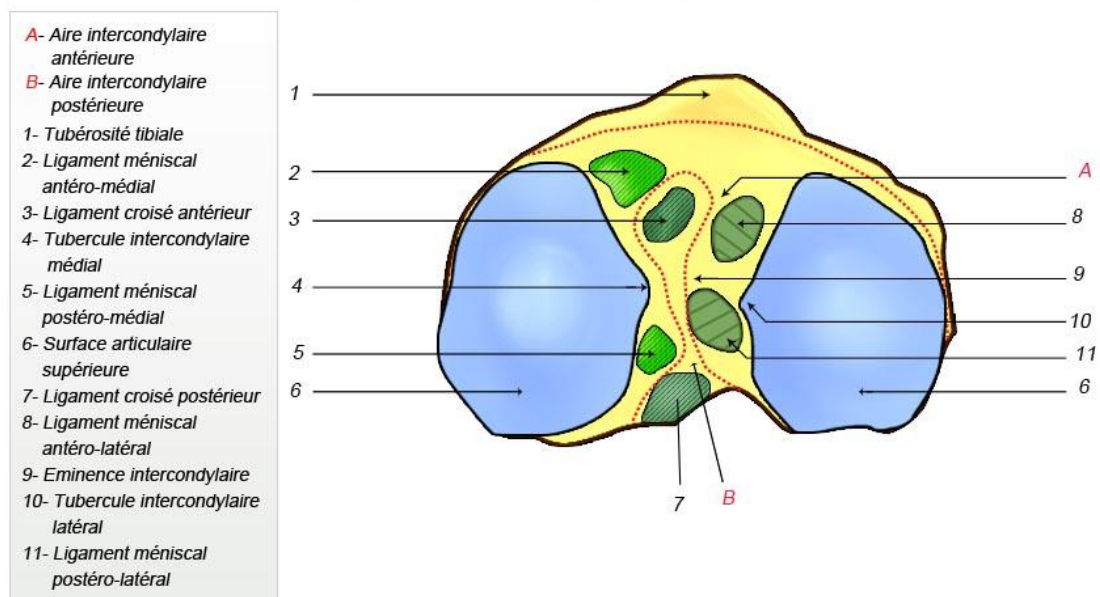


Fig.5: Condyles du tibia (vue supérieure)



LE TIBIA

I-DEFINITION:

A long, voluminous, paired, asymmetrical bone that forms the skeleton of the leg together with the fibula. Located in the middle of the leg, inside the fibula. It articulates:

- at the top: with the femur, forming the femorotibial joint, and with the fibula, forming the proximal tibiofibular joint.
- and at the bottom with the talus, forming the talocrural joint, and with the fibula, forming the distal tibiofibular joint.

II-DIAPHYSE:

The body is prismatic and triangular and has three faces and three edges.

1. LATERAL FACE: the upper half has a depression where the tibialis anterior muscle inserts.
2. MEDIAL SURFACE: smooth and subcutaneous, except for its upper part, which has rough areas that provide insertion for the sartorius, gracilis and semitendinosus muscles.
3. POSTERIOR SURFACE: crossed at its upper part by a crest; this is the oblique line of the tibia, which provides insertion for the soleus muscle. This line divides the posterior surface of the tibia into two segments: an upper, triangular segment, which provides attachment for the popliteus muscle; and a lower segment, subdivided by a vertical crest into two parts: a medial part, which provides insertion for the flexor digitorum communis muscle, and a lateral part for the posterior tibial muscle.

The main nutrient foramen of the bone is generally located slightly below the oblique line of the tibia.

4. ANTERIOR EDGE: prominent and sharp; this is the crest of the tibia. It disappears at the top of the tibial tuberosity.
5. LATERAL EDGE: called the interosseous edge, it provides insertion for the interosseous membrane of the leg.
6. MEDIAL EDGE: not very pronounced.

III-PROXIMAL EPIPHYSE: pyramid-shaped with an upper base.

It has a base or tibial plateau and two tuberosities or condyles.

1-THE TIBIAL PLATEAU OR SUPERIOR ARTICULAR SURFACE OF THE TIBIA:

It has three parts: two lateral articular parts, the glenoid cavities, and a middle part, the interglenoid space.

The glenoid cavities are one external and one internal. They articulate with the condyles of the femur.

LE TIBIA

At their inner part, they rise to form an eminence, the intercondylar eminence, which occupies the middle part of the intercondylar space.

The intercondylar space is divided into three parts: a middle part and two other parts, the anterior and posterior intercondylar areas.

2-LATERAL CONDYLE: it has:

-on the outside and rear, the fibular articular surface for the head of the fibula.

-on the outside and front, Gerdy's tubercle, which provides insertion for the tibialis anterior muscle and the fascia lata.

3- MEDIAL CONDYLE: it has:

- at the back, the insertion point of the direct tendon of the semimembranosus muscle.

4-TIBIAL TUBEROSITY: located at the front of the proximal epiphysis, it provides insertion for the patellar ligament.

IV-DISTAL EPIPHYSE:

Less voluminous than the upper end, it has a distal extension, the medial malleolus. It has an irregularly cubic shape and therefore has 5 faces:

1- THE ANTERIOR FACE: continues the lateral face of the diaphysis and has a transverse ridge that provides insertion for the capsule of the talocrural joint.

2- THE POSTERIOR FACE: has a groove through which the flexor hallucis longus tendon passes.

3- LATERAL FACE: hollowed out like a gutter, the fibular notch of the tibia where the distal end of the fibula is housed.

4- MEDIAL SURFACE: extends downwards into a large process, the medial malleolus, which forms a triangular protrusion with a lower apex. This malleolus has:

-a medial surface: is subcutaneous.

-a lateral surface: has an articular surface with the talus.

-an anterior edge.

- a posterior edge.

-an apex: attaches to the medial collateral ligament of the talocrural joint.

5-INFERIOR SURFACE: entirely covered with cartilage, quadrilateral, it is divided into two parts by a crest that corresponds to the groove of the talus trochlea.